



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

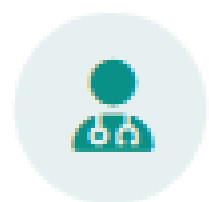
EVALUACIÓN CLÍNICA, ERGONÓMICA Y TECNOLÓGICA

Caso Paciente PCLP

Análisis Integral del Modelo PACT: Persona, Actividades, Contexto y Requerimientos de Tecnología Asistencial



Modelo PACT: Evaluación Integral



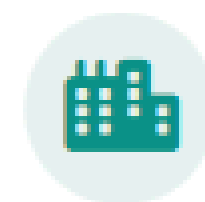
1. Persona

Varón de 29-30 años, lúcido, alta capacidad cognitiva y reflexiva. Lesión T10 AIS A y hemipelvectomía derecha.



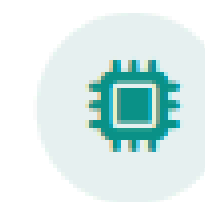
2. Actividad

AVD básicas, manejo de colostomía, transferencias, propulsión urbana y retorno a aulas universitarias.



3. Contexto

Residencia en Chorrillos con padres, veredas inaccesibles, uso de taxis y alta motivación por bipedestar.



4. Tecnología

Soporte postural asimétrico, alivio de presión anal/injerto, bipedestador dinámico y chasis ultraliviano.



Perfil Clínico y Cognitivo



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Capacidades Cognitivas

- **Estado Mental:** Totalmente lúcido y orientado en tiempo, espacio y persona.
- **Procesamiento Superior:** Destacada capacidad comunicativa, analítica y reflexiva.
- **Motivación Intrínseca:** Firme convicción de continuar su desarrollo profesional y retomar Ing. Industrial (8vo ciclo).

Diagnóstico Físico

- **Lesión Medular:** Severa nivel T10 AIS A (pérdida motora y sensitiva completa sublesional).
- **Resección Ósea:** Hemipelvectomía derecha que altera el triángulo de soporte pélvico.
- **Intervenciones:** Colostomía activa e injerto cutáneo por quemadura severa en muslo derecho.



Signos Vitales y Fisiología



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

120/80

P. ARTERIAL (MMHG)

60

FREC. CARDÍACA (BPM)

20

FREC. RESP. (RPM)

98%

SAT. O₂ (%)

Funciones Fisiológicas Conservadas

- **Estabilidad Hemodinámica:** Parámetros cardiorrespiratorios óptimos sin requerimiento de fármacos.
- **Función Bulbar Preservada:** Control motor oral intacto para habla clara, articulación fluida y deglución segura.
- **Autonomía Física:** Capacidad actual de bipedestación con andador y potencial pleno para manejo independiente de silla de ruedas.



Análisis de Actividades

Demandas Funcionales

El paciente ejecuta AVD básicas (higiene, alimentación, manejo de bolsa de colostomía) y transferencias desde la silla de ruedas hacia la cama y sanitario.

Requiere cambios posturales constantes para aliviar la presión por prolapso rectal e injerto, además de propulsar su silla en entornos urbanos y universitarios.



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA



Contexto Social y Familiar

Red de Apoyo y Aspiraciones

Reside en Chorrillos junto a sus padres, quienes brindan un sólido soporte € al y económico mientras se encuentra desempleado.

Escribía el 8vo ciclo de Ingeniería Industrial antes del accidente; su meta central es retornar a la universidad, retomar deportes adaptados y lograr inserción laboral.

Expresa el firme deseo de interaccionar socialmente en posición de bipedestación para comunicarse "ojo a ojo" sin sentirse en desventaja física.





Barreras Físicas y Urbanas

-  **Infraestructura Vial Inaccesible:** Veredas deterioradas, bordillos altos y ausencia sistemática de rampas en la zona residencial de Chorrillos.
-  **Transporte Público Inadecuado:** Falta de unidades adaptadas; dependencia casi exclusiva de taxis con ayuda de terceros para cargar la silla.
-  **Incomodidad por Sedestación Prolongada:** Molestia constante por el prolapso rectal recurrente y la sensibilidad de la piel del injerto en el muslo.
-  **Desafíos en Campus Universitario:** Necesidad de desplazarse entre facultades, laboratorios y aulas sin fatiga excesiva ni riesgo de lesiones tisulares.



Inestabilidad Hemi-Pélvica

- Ausencia del apoyo ilíaco e isquiático derecho genera una inclinación pélvica lateral severa.
- Desequilibrio de cargas sobre la pelvis izquierda, aumentando la tensión muscular en tronco y columna.
- Elevado riesgo a mediano plazo de desarrollar escoliosis estructurada e insuficiencia postural.

Vulnerabilidad de Tejidos Blandos

- La presión centrada sobre el prolapso rectal genera incomodidad y peligro de fricción/ulceración.
- La piel trasplantada en el muslo posterior derecho posee baja tolerancia al cizallamiento y maceración.
- Se requiere una distribución personalizada de fuerzas sin comprimir la zona abdominal/colostomía.



Tecnología: Asiento Postural

Requerimientos de Interfaz de Sedestación

- **Compensación Aplanada Hemi-Pélvica:** Cojín conformador con bloque o suplemento ergonómico derecho que nivela las crestas ilíacas y estabiliza el tronco.
- **Canal de Relieve Anal y Sacro:** Escotadura central descargada de presión para prevenir contacto directo con el prolapso rectal y el injerto.
- **Compatibilidad de Arnés:** Sistema de retención pélvica a 45° que no comprima ni interfiera con el drenaje de la bolsa de colostomía.





- **Descarga Dinámica de Carga:** Bipedestador asistido o silla con módulo de elevación que distribuye el peso de forma equilibrada en la extremidad izquierda.
- **Corrección de Compensaciones:** Previene la hiperpronación y rotación externa excesiva del pie/rodilla izquierdo durante la posición erguida.
- **Inclusión y Salud Orgánica:** Permite la interacción visual cara a cara ("ojo a ojo"), favoreciendo el tránsito intestinal y la densidad ósea.

